



MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : 444/I.6/H/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Edaran Terakhir Undangan Rakernas MPKU 2025**

Jakarta, 04 Muharram 1446 H
30 Juni 2025 M

Kepada Yth;

1. Ketua Majelis, Lembaga dan Biro PP Muhammadiyah
2. Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyiyah
3. Ketua dan Sekretaris Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Se-Indonesia
4. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bidang Kesehatan seluruh Indonesia
5. Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah seluruh Indonesia
6. Badan Pembina Harian (BPH) RS Muhammadiyah Aisyiyah
7. Direksi RS Muhammadiyah Aisyiyah seluruh Indonesia
8. Kepala Klinik Muhammadiyah Aisyiyah seluruh Indonesia
9. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah seluruh Indonesia
10. Manager/Kepala Bagian Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah seluruh Indonesia
11. Forum IT Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah seluruh Indonesia

Di Tempat

اَللّٰهُمَّ عَلٰى كُلِّ مَرْكَبٍ رَّحْمَةً وَّ بَرَكَاتٍ

Teriring salam semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT., sehingga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari diberikan kemudahan dan kesuksesan. Aamiin.

Rencana Strategis MPKU 2023–2027 menempatkan tahun 2025 sebagai fase krusial dengan fokus pada perluasan jaringan dan penguatan layanan (MPKU PP Muhammadiyah, 2024). Target tersebut tidak hanya melibatkan pertumbuhan jumlah RSMA dan KMA, tetapi juga peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui standarisasi berbasis nilai Islami, adopsi teknologi informasi kesehatan, dan integrasi sistem layanan primer dan sekunder.

Oleh karena hal tersebut MPKU Muhammadiyah akan menyelenggarakan **"MPKU Award, Workshop dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 dengan tema "Transformasi Kesehatan Muhammadiyah Kolaborasi dan Inovasi"**, yang Insya Allah akan diselenggarakan:

Workshop 1: Executive Forum – Leadership for Transformative Collaboration

Workshop 2: Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di era Transformasi Pelayanan Kesehatan Nasional: Tinjauan, Kesiapan, dan Kesempatan RSMA dalam menghadapi perubahan regulasi menjadi I DRG

Workshop 4: Sinergi dan kolaborasi Majelis/Lembaga/Ortom

Hari, Tanggal	: Kamis, 17 Juli 2025 M/21 Muharram 1447 H
Tempat	: Morazen Hotel - Jalan Nasional III Yogyakarta, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo
Pendaftaran	: https://rakernas.mpku.or.id/
Narahubung	: WS 1 Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR (0815-4852-8523) WS 2 drg. Indria Nehriasari, SpBM., MPH (0856-4627-0511) WS 4 Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes. (0855-1000-005)
TOR	: Terlampir

Alamat

Jl. Menteng Raya No. 62, Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon

021-3911915

Email

mpkuppmmuh@gmail.com



MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Workshop 3: Digitalisasi Sistem Pelayanan RSMA – Strategi Interoperabilitas, Efisiensi, dan Keamanan Data

Hari, Tanggal : Kamis – Jum'at, 17 – 18 Juli 2025 M/21 – 22 Muharram 1447 H
Tempat : Hotel Ibis – Jl. Wates - Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta 55654
Pendaftaran : <https://rakernas.mpku.or.id/>
Narahubung : dr. Nurcholid Umam, Sp.A., M.Kes (0817-264-563)
TOR : Terlampir

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MPKU 2025

Hari, Tanggal : Jum'at - Sabtu, 18 – 19 Juli 2025 M/22 – 23 Muharram 1447 H
Tempat : Morazen Hotel - Jalan Nasional III Yogyakarta, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo
Pendaftaran : <https://rakernas.mpku.or.id/>
Narahubung : Didin Sahidin, SKM., MKM. (0812-9864-2109)
Dimas Catur Ihtifazhuddin, S.Kom. (0856-9706-0891)
Mei Rizki Dini, Amd. (0813-2887-3333)
TOR : Terlampir

Pembayaran SWO dan SWP dapat ditransfer ke Bank Muamalat Indonesia nomor rekening: 3010228300, atas nama MPKU PP MUHAMMADIYAH, bukti transfer dikirim ke Sdri. Eka Wulandari, S.Sos., MM. : HP/WA. 0812-1463-7612.

Demikian edaran terakhir ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Nashrunminallahwafathunqariib,

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

MPKU PP MUHAMMADIYAH

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM
NBM : 551.318



Sekretaris,

Ekorini Listiowati

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR
NBM ; 908 340

Tembusan;

1. PP Muhammadiyah Jakarta – Yogyakarta
2. Pimpinan Harian MPKU PP Muhammadiyah
3. Arsip

Alamat

Jl. Menteng Raya No. 62, Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon

021-3911915

Email

mpkuppnuh@gmail.com

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
XBTVH-PORCK-MSU9M-FBIUQ

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
30 JUN 2025 22:36:49 UTC

SIGNER

TIMESTAMP

SIGNATURE

EKORINI LISTIOWATI

EMAIL
EKORINIKHOLID@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
30 JUN 2025 12:55:10 UTC

VIEWED
30 JUN 2025 13:06:46 UTC

SIGNED
30 JUN 2025 13:09:31 UTC

Ekorini Listiowati

IP ADDRESS
103.119.66.88

LOCATION
JAKARTA, INDONESIA

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
30 JUN 2025 12:55:10 UTC

VIEWED
30 JUN 2025 22:34:38 UTC

SIGNED
30 JUN 2025 22:36:49 UTC

M. Agus Samsudin

IP ADDRESS
103.18.34.237

LOCATION
DEPOK, INDONESIA



PROPOSAL KEGIATAN
LAUNCHING and FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kolaborasi Lintas Majelis/Lembaga/Ortom: Penguatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Sosial Berbasis Komunitas melalui Gerakan “Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan: Siapkan Generasi Sehat, Tangguh dan Berkemajuan”

I. Latar Belakang

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Berkemajuan dengan struktur organisasi yang berbasis dakwah komunitas memiliki potensi besar dalam penguatan kesehatan masyarakat, terutama di tengah tantangan masalah kesehatan nasional maupun global seperti TBC, stunting, pernikahan anak, penyakit tidak menular dan menular (Covid-19), kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja, anemia remaja putri, skabies di pesantren, rokok, dan isu kesehatan mental/jiwa.

Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah memegang peran sentral dalam penyelenggaraan dan pengembangan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif pada komunitas, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dhuafa. Melalui bidang Kesmas, program kolaborasi dalam kesehatan masyarakat dengan berbagai pihak telah terselenggara beberapa program yaitu Sekolah Sehat Berkemajuan, Pesantren Sehat Berkemajuan, Aku Suka Isi Piringku/Sehat Bersama Isi Piringku, yang menghasilkan kader kesehatan Muhammadiyah di sekolah/madrasah/pesantren, serta pedoman pelaksanaannya untuk menjadi panduan keberlanjutannya di amal-amal usaha Muhammadiyah terkait, dengan disertai pula Srat Edaran Linta Majlis (MPKU, Majelis Dikdasmen dan PNF, serta LP2PPM) terkait Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan. Selanjutnya, MPKU terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas, merata, dan berkelanjutan, namun tantangan masalah kesehatan masyarakat yang berkembang saat ini memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas majelis dan lembaga. Untuk saat ini, MPKU melibatkan beberapa lembaga dan majlis yang sangat potensial, yaitu:

1. Majelis Pelayanan Sosial (MPS), salah satu unsur pembantu pimpinan dalam organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang pelayanan sosial. MPS berperan menjalankan tugas menggerakkan dan menyatukan potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta mengembangkan kemitraan. Bentuk pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan sosial antara lain adalah *ambulance* Muhammadiyah, rumah singgah, dan pendampingan panti asuhan.
2. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) menjadi pengelola utama dana filantropi yang strategis dalam mendukung pembiayaan program sosial dan kesehatan.
3. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCR-PM) berperan sebagai katalisator yang memfasilitasi dan mendukung kegiatan cabang dan ranting, membantu pembentukan kader kesehatan masyarakat di tingkat ranting, dan bukan pelaksana langsung. LPCR dan Pembinaan Masjid juga mengoptimalkan jaringan masjid dan ranting sebagai pusat edukasi, pemberdayaan, dan mobilisasi masyarakat.
4. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) berkontribusi dalam edukasi, riset, inovasi, pengabdian masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Islami di bidang kesehatan masyarakat.

Sinergi dan kolaborasi lintas majelis antara MPKU, MPS, LPCR-PM, dan LazisMU menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang holistik dan inovatif, sekaligus memperkuat pemberdayaan sosial dengan fokus pada panti asuhan Muhammadiyah. Launching dan *Focus Group Discussion* (FGD) ini bertujuan memperkuat kolaborasi, merancang program inovatif lintas majelis, serta meluncurkan *pilot project* berupa Gerakan Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan yang berdampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat wilayah dan cabang, dan menyiapkan Generasi Muhammadiyah yang Sehat, Tangguh dan Berkemajuan.

II. Tujuan Kegiatan

- Meluncurkan program kolaboratif kesehatan masyarakat lintas majelis di tingkat nasional sebagai *pilot project* : **Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan: Siapkan Generasi Sehat, Tangguh dan Berkemajuan**
- Meningkatkan pemahaman program kolaboratif dan sinergis antar majelis dan lembaga Muhammadiyah dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial.
- Merancang program kesehatan masyarakat yang inovatif dengan berbagi peran antara MPKU, MPS, LazisMu, LPCR-PM, dan PTMA.
- Menyusun rencana tindak lanjut kolaborasi program dan pembentukan tim koordinasi lintas majelis untuk monitoring, evaluasi dan menjamin keberlanjutan program.

III. Tema Kegiatan

Kolaborasi Lintas Majelis/Lembaga/Ortom: Penguatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Sosial Berbasis Komunitas melalui Gerakan “Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan: Siapkan Generasi Sehat, Tangguh dan Berkemajuan”

IV. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025
Waktu : 13.00 – 19.30 WIB
Tempat : Hotel Morazen, Kulonprogo – Yogyakarta

V. Peserta

- MPKU Wilayah: 30 orang.
- Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah: 1 orang
- LazisMu PP Muhammadiyah: 1 orang
- Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCR-PM) PP Muhammadiyah: 1 orang
- *Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN)*; 1 orang
- Perwakilan PTMA: 13 orang
- UNISA Se Indonesia: 4 orang

Total peserta ± 51 orang

VI. Output yang diharapkan

- Dokumen strategi pemberdayaan bidang sosial dan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dan sinergi lintas majelis/lembaga/ortom.
- Dokumen kerangka kerja duplikasi program kolaborasi Kesehatan Masyarakat lintas Majelis, Lembaga, dan ortom untuk melaksanakan program pemberdayaan sosial di tingkat wilayah. Rancangan program MPKU Wilayah mencakup: tujuan, peran masing-masing majelis, sumber daya, lokasi *pilot project*, indikator keberhasilan, dan *timeline* kegiatan.

VII. Rencana Kegiatan

- Launching* program kolaborasi dan sinergi program kesehatan masyarakat lintas majelis/lembaga/ortom.
- Forum Group Discussion* (FGD) rencana duplikasi program di tingkat wilayah.

VIII. Narasumber

- Wakil Ketua IV Majelis Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah
- Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT)
- Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

IX. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	PIC
13.00-13.30	Pembukaan, dan Tilawah Sambutan: 1. Wakil Ketua IV MPKU PP Muhammadiyah: Dr. Dra. Emma Rachmawati., M.Kes 2. Pengantar dan pembukaan acara oleh, Ketuaa MPKU PP Muhammadiyah Dr. H. M. Agus Samsudin,MM	MC: Lia Karisma Saraswati, M.Kes Tilawah:
13.30-14.30	Paparan Program dan Arah Strategis Majelis Narasumber: Wakil Ketua IV Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah	Moderator: Yuniar Wardani, S.KM.MPH,Ph.D Dr. Dra. Emma Rachamawati., M. Kes
14.30-15.00	Launching program sinergi dan kolaborasi program kesehatan masyarakat lintas majelis, lembaga, dan ortom: Gerakan “Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan: Siapkan Generasi Sehat, Tangguh dan Berkemajuan”	Tim Kesmas MPKU PPM , UMKT dan UM Pare-Pare
15.00-15.30	ISHOMA	
15.30- 17.00	Best practice, monitoring. evaluasi dan keberlanjutan program	Moderator: Lia Karisma Saraswati, M.Kes a. Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) b. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pare-Pare
17.00-18.00	Diskusi untuk rencana duplikasi program di masing-masing wilayah	Moderator: Dr. Husnan Nurjuman, S.Ag. M.Si
18.00-18.30	Shalat Maghrib & Coffee Break	Panitia
18.30-19.00	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Penetapan Program Unggulan	Tim Kesmas
19.00-19.30	Penutupan, Doa	Tim Kesmas

X. Diskusi Kelompok/FGD

Tema Diskusi: Merancang duplikasi program kolaboratif bidang kesehatan masyarakat dengan peran aktif MPKU, MPS, LazisMu, LPCR-PM, dan PTMA. Setiap MPKU wilayah menghasilkan rancangan program dengan: tujuan, peran masing-masing majelis, sumber daya, lokasi *pilot project*, indikator keberhasilan, dan *timeline* kegiatan.

XI. Rencana Tindak Lanjut

- Dokumentasi hasil diskusi dan program yang dirancang
- Penjadwalan pertemuan koordinasi dan monitoring
- Evaluasi berkala dan pelaporan hasil program

XII. Penutup

Launching program kolaboratif dan inovatif menegaskan komitmen bersama menuju pengabdian yang lebih efektif dan sinergis. *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi momentum penting dalam menguatkan kolaborasi lintas majelis, lembaga dan ortom Muhammadiyah untuk menghadirkan program kolaboratif dan inovatif nyata dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Jakarta, 20 Juni 2025 M / 24 Dzulhijjah 1446 H
Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

PJ WS Kesmas,

M. Agus Samsudin

Emma Rachmawati

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM.

NBM : 551.318

Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.

NBM : 1057.594

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
JQJNQ-CQHPE-RDJHV-DTUIU

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
20 JUN 2025 04:08:43 UTC

SIGNER

EMMA RACHMAWATI

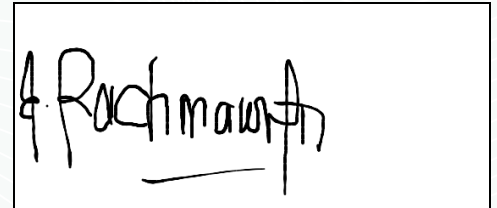
EMAIL
EMMA.UHAMKA@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

TIMESTAMP

SENT
20 JUN 2025 03:15:04 UTC
VIEWED
20 JUN 2025 03:28:48 UTC
SIGNED
20 JUN 2025 03:29:49 UTC

SIGNATURE



IP ADDRESS
110.138.82.77

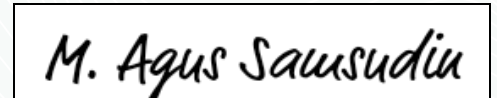
LOCATION
JAKARTA, INDONESIA

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
20 JUN 2025 03:15:04 UTC
VIEWED
20 JUN 2025 03:30:58 UTC
SIGNED
20 JUN 2025 04:08:43 UTC



IP ADDRESS
118.96.182.44

LOCATION
SLEMAN, INDONESIA



Term of Reference (TOR)

Workshop Forum IT Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah : “Meningkatkan Kapasitas Digital Rumah Sakit Muhammadiyah–Aisyiyah dalam Integrasi SATU SEHAT, Keamanan Siber, Interoperabilitas Layanan dan Kesiapan Rumah Sakit dalam Penggunaan iDRG”
Pra-Rakernas MPKU PP Muhammadiyah 2025 Ibis Yogyakarta
International Airport Kulon Progo Yogyakarta, 17-18 Juli 2025

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan mengalami percepatan pesat, terutama pasca implementasi kebijakan SATU SEHAT dan regulasi keamanan data pribadi. RS Muhammadiyah–Aisyiyah sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional perlu memperkuat kapabilitas IT untuk memastikan keberlanjutan digitalisasi layanan, interoperabilitas data, dan tata kelola informasi yang aman dan efisien.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas tim IT RSMA terhadap regulasi dan sistem nasional.
- Menyusun roadmap digitalisasi RS Muhammadiyah–Aisyiyah secara kolektif.
- Meningkatkan pemahaman petugas rumah sakit terhadap sistem iDRG.
- Meningkatkan akurasi pengkodean diagnosis dan prosedur dengan ICDIM.
- Mendorong kolaborasi lintas unit dalam manajemen klaim.
- Mempersiapkan petugas IT untuk penginstalan aplikasi INA grouper.
- Memperkuat jaringan kolaborasi antar tim IT RSMA se-Indonesia.

3. Tema Kegiatan

“Meningkatkan Kapasitas Digital Rumah Sakit Muhammadiyah–Aisyiyah dalam Integrasi SATU SEHAT, Keamanan Siber, Interoperabilitas Layanan dan Kesiapan Rumah Sakit dalam Penggunaan iDRG”

4. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, Jumat 17-18 Juli 2025
Tempat : Hotel Ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo

5. Peserta

- Tim IT dari seluruh RS Muhammadiyah–Aisyiyah se-Indonesia
- Coder RSMA se Indonesia
- Tim Keuangan Rumah Sakit
- Perwakilan Direksi, MPKU PWM & MPKU PDM
- Undangan mitra strategis
- Tim Casemix

6. Materi Kegiatan

- Strategi Transformasi Digital Kesehatan Nasional
- Integrasi SIMRS dengan SATU SEHAT dan platform Kemenkes
- Keamanan Siber dan Audit Informasi RS
- Pemanfaatan AI dan Teknologi Cloud dalam SIMRS
- Workshop teknis: Interoperabilitas, Enkripsi, dan Audit Keamanan serta Klaim BPJS
- Transisi Koding Klinis Ina Cbg ke iDRG Modification

7. Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar nasional, sesi paralel workshop teknis, diskusi kelompok, dan penyusunan rekomendasi bersama.

8. Penyelenggara

Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
– Divisi IT Nasional.

Rundown Kegiatan

Workshop Nasional IT RSMA – Yogyakarta Kamis – Jum'at, 17 – 18 Juli 2025

Hari I – Kamis, 17 Juli 2025

Kelas Gabung

Waktu	Acara	PEMATERI	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia	Oki Wahyu N,S.Kom
08.30 – 08.35	Pembukaan	Panitia	Sutahar, S.T
08.35 - 08.45	Indonesia Raya dan Sang Surya	Panitia	
08.45 - 09.00	Sambutan MPKU PP Muhammadiyah	Ketua MPKU PP Muhammadiyah	
09.00 – 10.30	Arah Transformasi Digitalisasi dan Keamanan Data RME	Dr. Agus Mutamakin, Phd (<i>Dewan Pakar MPKU</i>)	Ir. Suryanto Nugroho., M.Kom., MPM., MBA
10.30 – 11.30	Integrasi EMR dengan Klaim BPJS dan Digitalisasi Pelayanan serta BPJS Trustmark	Kepala Bagian ITBPJS Wilayah VI	Gatot Purnomosidi S.Kom
11.30 - 12.00	Tanya Jawab	Kepala Bagian ITBPJS Wilayah VI	Gatot Purnomosidi S.Kom
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 – 15.00	Finalisasi KFA, LOINC, SNOMED & Metadata RSMA - Mapping - Kirim data	Oki Wahyu N,S.Kom	Andik Hermawan S.Kom
15.00 – 16.30	Integrasi AI dalam EMR dan Automasi Klinis	Ismail Fahmi, Ph.d	Anwar Siswanto, S.Kom. M.Kom
16.30 – 18.00	Transisi Sistem Klaim Berbasis IDRG	Ir. Suryanto Nugroho., M.Kom., MPM., MBA	Sutahar, S.T
18.00 - 19.30	ISHOMA		
19.30 - 20.30	SehatMU	LabMu	Ir. Suryanto Nugroho., M.Kom., MPM., MBA
20.30 - 21.30	Forum IT		Gatot Purnomosidi S.Kom

Hari II – Jum'at, 18 Juli 2025
Kelas IT

Waktu	Acara	PEMATERI	PIC
08.00 – 09.30	Alur Integrasi Satu sehat dengan klaimJKN	TSDK (Tim Transformasi Digital Kesehatan) Kemenkes RI (DTO)	Sutahar, S.T
09.30 – 11:00	Standar KPTL	TSDK (Tim Transformasi Digital Kesehatan) Kemenkes RI (DTO)	Sutahar, S.T
11.00 – 11.30	Tanya jawab	TSDK (Tim Transformasi Digital Kesehatan) Kemenkes RI (DTO)	Sutahar, S.T
11.30 - 13.00	ISHOMA		
13.00 – 14.00	Mengirim data Dicomke satu sehat dicom router	TSDK (Tim Transformasi Digital Kesehatan) Kemenkes RI (DTO)	Andik Hermawan S.Kom
14:00 - 14:10	Penutup	Panitia	

Kelas CODER

Waktu	Acara	PEMATERI	PIC
08.00 – 09.30	Transisi Koding KlinisIna Cbg ke IDRG Modification	Tim Pubikes Kemenkes	Arif Riyanto,S.Kep,Ns
09.30 – 10:30	Kupas Tuntas Indonesian Coding Standard dalam IDRG	Tim Pubikes Kemenkes	Arif Riyanto,S.Kep,Ns
10.30 – 11.30	MDCG (Medical Device Coordination Group) dalam IDRG	Tim Pubikes Kemenkes	Arif Riyanto,S.Kep,Ns
11.30 - 13.00	ISHOMA		
13.00 – 14.00	Tanya jawab	Tim Pubikes Kemenkes	Arif Riyanto,S.Kep,Ns
14:00 - 14:10	Penutup	Panitia	

Kelas Gabung

Sesi 1 : Arah Transformasi Digitalisasi dan Keamanan Data RME

Narasumber : Dr. Agus Mutamakin, Phd (*Dewan Pakar MPKU*)

Sejalan dengan pilar keempat transformasi sistem kesehatan Indonesia, transformasi teknologi kesehatan merupakan prioritas utama Kementerian Kesehatan RI periode 2021–2029. Melalui inisiatif SATUSEHAT, pemerintah mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit untuk menyelenggarakan layanan kesehatan berbasis data yang saling terintegrasi, terbuka, dan aman. Salah satu komponen kunci dalam transformasi ini adalah Rekam Medis Elektronik (RME) yang tidak hanya menjadi sarana dokumentasi klinis, tetapi juga menjadi fondasi interoperabilitas dengan sistem pembiayaan (BPJS/INA-CBGs/IDRG), pelaporan nasional, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Dengan demikian, keamanan data dan perlindungan privasi pasien menjadi sangat vital, terutama menyongsong penerapan penuh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan pemutakhiran regulasi Kementerian Kesehatan melalui KPTL. Sehingga peserta mampu :

1. Memberikan pemahaman tentang arah kebijakan transformasi digital sistem kesehatan Indonesia (khususnya SATUSEHAT & RME).
2. Menjelaskan arsitektur referensi digitalisasi RS, integrasi FHIR API, dan kerangka RME yang ditetapkan Kemenkes.
3. Menjabarkan prinsip keamanan informasi dan perlindungan data pasien dalam konteks sistem RME.
4. Mendorong peserta memahami urgensi reformasi sistem EMR lokal agar sesuai regulasi dan teknologi nasional/global.

Sesi 2 : Integrasi EMR dengan Klaim BPJS dan Digitalisasi Pelayanan serta BPJS Trustmark

Materi 1 : Integrasi EMR dengan Klaim BPJS dan Digitalisasi Pelayanan

Narasumber : KaBag IT BPJS Wilayah VI

Materi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana integrasi **Electronic Medical Record (EMR)** dengan sistem klaim BPJS Kesehatan dapat mendorong efisiensi dan akurasi dalam pelayanan serta proses klaim. Fokus pembahasan meliputi:

1. Peran EMR dalam memperkuat dokumentasi medis dan meningkatkan akurasi coding diagnosis dan prosedur.
2. Integrasi sistem informasi rumah sakit (SIRS) dengan **P-Care, VClaim, dan INA-DRG Grouper**, termasuk alur data dari pelayanan ke klaim.
3. Tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam digitalisasi data pelayanan dan pengiriman klaim real-time ke BPJS.
4. Studi kasus rumah sakit yang berhasil mengimplementasikan sistem terintegrasi antara EMR dan klaim BPJS.
5. Rekomendasi langkah-langkah teknis dan strategis dalam menyusun blueprint integrasi EMR dengan digitalisasi pelayanan.

Materi 2 : BPJS Trustmark Menjamin Keamanan dan Kualitas Data dalam Ekosistem JKN

Narasumber : KaBag IT BPJS Wilayah VI

Materi ini memberikan penjelasan tentang inisiatif BPJS Trustmark, yaitu sistem penjaminan mutu dan keamanan dalam pengelolaan data digital rumah sakit dan klaim JKN. Materi yang mencakup:

1. Penjelasan tentang borang trustmark
2. Peserta melakukan teknis pengisian borang BPJS Trustmark.
3. Melakukan bimbingan terhadap peserta terhadap borang BPJS Trustmark

Sesi 4 : Integrasi AI dalam EMR dan Automasi Klinis

Narasumber : Ismail Fahmi

Materi ini memaparkan tentang pentingnya Digitalisasi sistem pelayanan rumah sakit yang telah menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan tuntutan efisiensi, akurasi data, dan peningkatan mutu layanan. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi salah satu teknologi kunci dalam **mempercepat transformasi** tersebut, terutama dalam **pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) dan proses-proses klinis yang berulang**. Integrasi AI dalam EMR diharapkan dapat membantu penyedia layanan kesehatan dalam menganalisis data pasien, mempercepat pencatatan medis, serta menghasilkan laporan yang akurat dan real-time. Sementara itu, proses klinis yang terotomasi mampu **menurunkan** beban kerja tenaga kesehatan dan **meningkatkan** keselamatan pasien. Maka sebagai bentuk komitmen RSMA dalam transformasi digital, workshop ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengadopsi dan mengembangkan sistem AI di lingkungan rumah sakit.

Narasumber diharapkan :

1. Menyampaikan konsep dan implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME/EMR) / *discuss with AI*.
2. Memahami prinsip dan contoh penerapan automasi proses klinis berbasis AI di rumah sakit.
3. Menjelaskan potensi AI dalam mendukung pembuatan laporan rumah sakit secara cepat dan tepat.
4. Peran AI bagi tim casemix rumah sakit untuk membantu proses klaim ke BPJS

Sesi 6 : Sehat-MU

Narasumber : Lab-Mu

Materi ini memaparkan tentang era **digitalisasi** kesehatan, **kebutuhan** akan sistem informasi yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses oleh publik serta internal fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) semakin mendesak. Saat ini, data dan informasi terkait kesehatan masih tersebar di berbagai sistem dan platform yang tidak saling terhubung. Hal ini menyulitkan proses pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi yang cepat dan berbasis data. Menjawab tantangan tersebut, Muhammadiyah dan Aisyiyah mengembangkan **SehatMu** sebagai pusat informasi kesehatan yang berbasis portal daring. Narasumber untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk publik maupun internal fasyankes Muhammadiyah dan Aisyiyah, seperti Rumah sakit dan klinik maka dibuatlah SehatMu.

Narasumber untuk bisa Mensosialisasikan konsep dan manfaat SehatMu kepada para pemangku kepentingan.

1. Memberikan gambaran teknis tentang cara mengakses, mengisi, dan memanfaatkan data dalam SehatMu.
2. Mendorong sinergi pengelolaan informasi kesehatan di lingkungan fasyankes Muhammadiyah.
3. Memperkenalkan pemanfaatan data untuk monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan (decision support system).
4. Rebranding SehatMu oleh Ketua MPKU PP Muhammadiyah
5. Pemberian penjelasan mengenai benefit bagi RSMA yang mengikuti program SehatMu.

Kelas IT

Sesi 1 : Alur Integrasi Satu sehat dengan klaim JKN

Narasumber : Tim Transformasi Digitalisasi Kesehatan (DTO) Kementerian Kesehatan

Paparan ini menekankan pentingnya keselarasan antara transformasi digital sistem kesehatan, khususnya integrasi platform *Satu Sehat* dengan proses klaim JKN. Narasumber diharapkan merefleksikan bagaimana akselerasi digitalisasi layanan kesehatan, tuntutan standarisasi data, dan penguatan interoperabilitas dapat dijalankan secara strategis. Narasumber juga memaparkan bagaimana perubahan alur dalam use case satu sehat integrasi klaim JKN. Terakhir narasumber melakukan demo pengiriman data dummy satu sehat. Sesi ini menjadi ruang kontemplatif untuk meneguhkan komitmen RSMA dalam membangun ekosistem digital yang tidak sekadar efisien dan terintegrasi, tetapi juga berlandaskan nilai keadaban, spiritualitas, serta keberpihakan kepada kemaslahatan masyarakat luas.

Sesi 2 : Sistem KPTL

Narasumber : Tim Transformasi Digitalisasi Kesehatan (DTO) Kementerian Kesehatan

Paparan ini menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap sistem kode pembiayaan tindakan dan layanan kesehatan sebagai elemen strategis dalam pengelolaan klaim JKN di lingkungan RSMA. Narasumber diharapkan mengulas bagaimana pemanfaatan kode KPTL menjadi landasan administratif dan finansial dalam proses klaim sesuai dengan regulasi. Narasumber diharapkan juga menekankan bahwa diperlukan mapping kode KPTL untuk di terapkan ke integrasi satuselamat ke klaim JKN, mapping ini diperlukan karena KPTL menjadi standar dalam pengiriman data billing rumah sakit yang akan digunakan untuk verifikasi klaim JKN. Selanjutnya, narasumber juga membahas bagaimana cara melakukan mapping KPTL ke tarif rumah sakit sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan.

Sesi 3 : Mengirim data Dicom ke satu sehat menggunakan dicom router

Narasumber : Tim Transformasi Digitalisasi Kesehatan (DTO) Kementerian Kesehatan

Paparan ini menggarisbawahi peran strategis integrasi data citra medis (DICOM) ke dalam platform *Satu Sehat* sebagai bagian dari upaya digitalisasi menyeluruh sistem informasi kesehatan nasional. Narasumber diharapkan menjelaskan mekanisme pengiriman data DICOM dari modality (CT-Scan, MRI, X-Ray, USG) ke *Satu Sehat* melalui perantara *DICOM Router* sebagai solusi interoperabilitas yang aman, efisien, dan terstandar. Proses ini mencakup pengelolaan metadata, konversi format, hingga kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pasien. Terakhir, narasumber melakukan demo pengiriman data menggunakan aplikasi dicom router. Untuk pengiriman data ke satuselamat wajib menggunakan file dengan format DICOM. tidak direkomendasikan pembelian alat analog

Kelas Coder

Sesi 1 : Transisi Koding Klinis Ina Cbg ke IDRG Modification

Narasumber : Tim Pubikes Kemenkes

Materi ini membahas secara komprehensif peralihan sistem pengkodean klinis dari INA-CBGs ke iDRG Modification yang digunakan dalam sistem JKN. Peserta akan memahami:

1. Perbedaan mendasar antara INA-CBGs dan iDRG, terutama dalam struktur klasifikasi, algoritma grupung, dan komponen biaya.
2. Perubahan dalam pendekatan pengkodean diagnosis dan prosedur serta pentingnya dokumentasi medis yang akurat dan lengkap.
3. Strategi rumah sakit dalam mengelola proses transisi agar tidak mengganggu kelancaran pengajuan klaim.
4. Tantangan yang muncul dalam proses transisi dan bagaimana rumah sakit dapat mengatasinya dengan pelatihan dan pembentukan tim koding yang kompeten. Sehingga peserta mampu mengidentifikasi gap dalam pengkodeansaat ini, serta menyusun rencana aksi untuk transisi yang efektif menuju sistem iDRG.

Sesi 2 : Kupas Tuntas Indonesian Coding Standard dalam IDRG

Narasumber : Tim Pubikes Kemenkes

Topik ini mengulas secara detail standar pengkodean diagnosis dan prosedur yang menjadi dasar dalam sistem iDRG. Fokus pembahasan meliputi:

1. Penjabaran **Indonesian Coding Standard** yang berperan sebagai panduan teknis dalam proses koding klinis.
2. Prinsip utama pengkodean yang akurat sesuai dengan ICD-10 dan ICD-9-CM versi modifikasi Indonesia.
3. Penerapan aturan utama pengkodean seperti *principal diagnosis*, *main procedure*, komorbiditas, dan komplikasi.
4. Studi kasus atau contoh konkret pengkodean dari rekam medis untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi. Sehingga peserta memahami standar nasional pengkodean dan mampu menerapkannya dalam proses dokumentasi dan klaim, sehingga mengurangi risiko pending atau tolak klaim dari BPJS Kesehatan.

Sesi 3 : MDCG (Medical Device Coordination Group) dalam IDRG
Narasumber : Tim Pubikes Kemenkes

MDCG merupakan kelompok koordinasi yang berperan dalam memastikan integrasi dan pembiayaan alat kesehatan dalam sistem iDRG. Dalam sesi ini, peserta akan mempelajari:

1. Fungsi MDCG dalam proses verifikasi dan klasifikasi alat kesehatan yang terkait dalam kelompok iDRG.
2. Pengaruh penggunaan alat kesehatan (termasuk alat implan, disposables, dan lainnya) terhadap nilai DRG dan biaya rumah sakit.
3. Proses input data alat kesehatan dalam sistem informasi rumah sakit untuk mendukung validitas klaim.
4. Peran lintas profesi (klinis, farmasi, rekam medis, keuangan) dalam pencatatan dan pelaporan alat kesehatan. Sehingga peserta memahami alur dokumentasi alat kesehatan yang sesuai dan peran koordinatif MDCG dalam mendukung transparansi biaya serta pengendalian klaim.

9. Penutup

Workshop ini merupakan tonggak awal dalam transformasi digital informasi kesehatan di lingkungan Muhammadiyah dan Aisiyah. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh fasyankes mampu berkontribusi aktif dalam penyediaan data yang berkualitas, transparan, dan berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Jakarta, 14 Juni 2025 M / 17 Dzulhijjah 1446 H
Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM.
NBM : 551.318

PJ WS Digitalisasi,

Nurcholid Umam

dr. Nurcholid Umam Kurniawan, Sp.A., M. Sc
NBM : 973.419

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
S8XMT-AVGUT-QAKGP-IGFUH

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
14 JUN 2025 23:44:33 UTC

SIGNER

NURCHOLID UMAM

EMAIL
DR_UMAM@YAHOO.COM

SHARED VIA
LINK

TIMESTAMP

SENT
14 JUN 2025 23:07:14 UTC

VIEWED
14 JUN 2025 23:15:06 UTC

SIGNED
14 JUN 2025 23:15:34 UTC

SIGNATURE

Nurcholid Umam

IP ADDRESS
114.10.150.98

LOCATION
SURAKARTA, INDONESIA

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
14 JUN 2025 23:07:14 UTC

VIEWED
14 JUN 2025 23:43:01 UTC

SIGNED
14 JUN 2025 23:44:33 UTC

M. Agus Samsudin

IP ADDRESS
103.18.34.237

LOCATION
JAKARTA, INDONESIA



Term of Reference
Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di RS Berbasis I- DRG (Indonesia-Diagnostic Related Group): Tinjauan, Kesiapan, dan Kesempatan RSMA

A. Latar Belakang

Transformasi kebijakan dalam sistem kesehatan nasional yang merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang No.17 th 2023 tentang Kesehatan , Peraturan Pemerintah No. 28 th 2024 dan Permenkes No. 16 th 2024, antara lain terdapat penerapan kebijakan strategis dalam tarif biaya pelayanan kesehatan yang akan digunakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . I- DRG yang akan digunakan sebagai dasar penentuan tarif menggantikan INA CBG's

I- DRG adalah sistem klasifikasi pasien berdasarkan diagnosa dan prosedur medis, kormobiditas dan tingkat keparahan yang dilakukan untuk tujuan pembayaran dan pengelolaan biaya kesehatan. Tujuan sistem ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penggantian biaya perawatan pasien, terutama dalam program JKN. Konsekuensinya, rumah sakit dituntut untuk memiliki kemampuan klinis, manajerial, dan sistem informasi yang terintegrasi dan siap pakai, demi menjaga keberlangsungan finansial dan kualitas layanan. Sistem ini juga memperkuat keterkaitan antara klaim pembayaran dengan jenjang kompetensi rumah sakit, yang akan menjadi dasar dalam menetapkan tarif layanan.

Perubahan kebijakan ini bagi RSMA mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya RS dan financial. Hal tersebut membuat dampak dan tantangan bagi RS, antara lain :

1. Biaya investasi berdasar rencana strategis yang tidak sejalan dengan arah kebijakan sistem kesehatan yang baru membuat nilai investasi yang merugi bagi RS
2. Pemahaman koding diagnosa penyakit masih terbiasa dengan dasar INA CBGs membutuhkan effort yang tinggi untuk penyesuaian dengan sistem I-DRG supaya tidak banyak loss cost dan keterlambatan pengajuan klaim yang akan mempengaruhi cashflow RS
3. Keterkaitan antara IDRG dengan RS berbasis Kompetensi , membuat kebutuhan biaya investasi untuk melengkapi kebutuhan yang disesuaikan dengan standar RS yang direncanakan dalam rencana strategis Rumah Sakit.

Dalam konteks tersebut, RSMA dituntut untuk bertransformasi dengan cepat dan adaptif, tanpa kehilangan misi sosial dan nilai keislaman dalam pelayanan. MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang perlu menyelenggarakan Workshop RS Muhammadiyah-’Aisyiyah, sebagai forum strategis untuk:

1. Meningkatkan pemahaman bersama terkait kebijakan tarif pelayanan Kesehatan berdasar IDRG. Bagi tenaga koding dan klinis yang masih terbiasa dengan skema INA-.CBG's membutuhkan pelatihan ulang
2. Mengidentifikasi kesiapan RSMA untuk mengetahui kesempatan yang dimiliki untuk dasar Menyusun rencana strategi dan transisi implementasi oleh RSMA.
3. Menyusun strategi manajemen keuangan karena adanya resiko disrupsi cashflow akibat keterlambatan atau kesalahan klaim karena SDM dan sistem informasi belum selaras dengan standar baru
4. Ancaman kerugian investasi akibat ketidaksesuaian antara rencana strategis rumah sakit dengan kebijakan klasifikasi berbasis kompetensi dan tarif I-DRG
5. Kesenjangan sarana dan prasarana, yang mempersulit rumah sakit untuk memenuhi standar sesuai klasifikasi layanan.
6. Merumuskan rekomendasi kelembagaan kepada Kementerian Kesehatan agar kebijakan tersebut inklusif, aplikatif, dan berpihak pada keberagaman kondisi rumah sakit di Indonesia, termasuk rumah sakit jejaring Muhammadiyah-’Aisyiyah.

Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, RSMA tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan forum strategis yang menjadi ruang konsolidasi, pembelajaran bersama, dan advokasi kolektif untuk memastikan bahwa transformasi ini tidak meninggalkan rumah sakit yang telah lama mengemban misi dakwah pelayanan kesehatan. Selain bersama-sama dalam mencari solusi strategis , semangat Ta'awun

diantara RSMA sebagai AUMKES milik persyarikatan perlu digali dan ditumbuhkan kembali guna membentuk ketahanan dalam hal financial, SDM, infrastruktur, system manajemen.

B. Tujuan dan Luaran

I. Tujuan Kegiatan

Workshop ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk mendukung transformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan berbasis I-DRG, dengan menekankan kesiapan, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap keberagaman kondisi rumah sakit jejaring Muhammadiyah–Aisyiyah. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif di lingkungan RS Muhammadiyah–Aisyiyah (RSMA) mengenai rancangan kebijakan nasional terbaru tentang Pembiayaan pelayanan Kesehatan berupa single tarif berbasis I-DRG, dan implikasinya terhadap tarif, klasifikasi layanan dan tata kelola klaim.
2. Mengidentifikasi tantangan, kesenjangan, dan kebutuhan RSMA dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan tersebut, baik dari aspek SDM, sarana-prasarana, sistem informasi, maupun manajerial.
3. Mengidentifikasi kesiapan dan tantangan guna menyusun peta jalan (*roadmap*) strategi kesiapan RSMA secara nasional maupun regional dalam memenuhi klasifikasi layanan berbasis kompetensi, dari aspek SDM, sarana prasarana, system informasi, maupun manajemen RS dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kesenjangan kapasitas antarrumah sakit.
4. Mendorong sinergi antar rumah sakit dan Majelis terkait, dalam hal advokasi, pemetaan potensi kolaborasi, serta upaya peningkatan kapasitas layanan sesuai jenjang kompetensi sebagai bentuk strategi adaptasi dan kolaborasi antar-RSMA, untuk memperkuat kapasitas teknis (terutama dalam hal koding, pelaporan, dan manajemen klaim), serta memperkuat ketahanan finansial dalam konteks perubahan pembiayaan JKN, juga bentuk saling Ta'awun dalam distribusi dana sosial berupa wakaf tunai dan infak di lingkup AUMKES.
5. Merumuskan rekomendasi kelembagaan MPKU PP Muhammadiyah yang akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan *stakeholder* lainnya agar kebijakan implementasi klasifikasi layanan RS dilakukan secara bertahap, adil, dan kontekstual terhadap kondisi RSMA di seluruh Indonesia, dengan memperhatikan keberagaman karakteristik dan misi sosial-keislaman RSMA.

II. Luaran yang Diharapkan

Dari pelaksanaan workshop ini, diharapkan diperoleh sejumlah luaran penting yang dapat menjadi dasar penguatan strategi RS Muhammadiyah–Aisyiyah dalam menyikapi kebijakan pembiayaan berbasis i-DRG, yaitu:

1. Dokumen pemetaan tantangan dan kesiapan RSMA terhadap implementasi kebijakan tentang Pembiayaan pelayanan Kesehatan berupa single tarif berbasis I-DRG, mencakup aspek SDM, infrastruktur, sistem informasi, dan keuangan rumah sakit.
2. Rumusan strategi dan langkah implementatif RSMA untuk meningkatkan kesiapan pengelolaan data dan pengajuan klaim rumah sakit Muhammadiyah–Aisyiyah sesuai dengan I-DRG, berupa penguatan kapasitas koding, pelaporan, dan pelatihan internal untuk pengurangan potensi klaim tertolak (*claim rejection*).
3. Rencana tindak lanjut kolaboratif antar RSMA untuk peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi dalam memenuhi standar nasional, sesuai jenjang klasifikasi kompetensi rumah sakit.
4. Rekomendasi resmi MPKU PP Muhammadiyah kepada pemerintah, sebagai masukan kebijakan berbasis data realitas lapangan agar kebijakan implementasi i-DRG dilakukan secara bertahap, inklusif, dan memperhatikan konteks serta misi sosial keislaman RSMA.
5. Penguatan jejaring dan koordinasi antar rumah sakit Muhammadiyah–Aisyiyah dalam menghadapi tantangan implementasi transformasi sistem pelayanan Kesehatan, yang dapat dimanfaatkan dalam advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan berbagi praktik baik dalam menghadapi perubahan sistem pembiayaan nasional.

C. Tempat dan Waktu :

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025
 Tempat : Hotel Morazen, Jalan Nasional III Yogyakarta – Purworejo KM 41.5, KM 41.5, Kec. Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY, 55654

D. Peserta Workshop

Peserta workshop ini terdiri dari:

1. Direktur Keuangan RSMA
2. Direktur Pelayanan Medik RSMA
3. Manajer Penunjang dan Pelayanan Medik
4. Manajer Keuangan
5. Manajer JKN/Casemix

Tema: Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di RS Berbasis i-DRG: Tinjauan, Kesiapan, dan Kesempatan RSMA

Waktu	Durasi	Agenda	Penanggung Jawab
08.30 – 09.00	30	Registrasi peserta dan pembukaan meja informasi - Coffee Break	Panitia: TIM MCF
09.00 – 09.15	15	Pembukaan dan Pengantar Strategis	MPKU PP Muhammadiyah dr. M. Syafak Hanung, Sp. A., MPH
09.15 – 10.00	45	Paparan Kebijakan Kemenkes: Pembiayaan Pelayanan Kesehatan RS berbasis i-DRG	Kepala Pusat Pembiayaan Kementerian Kesehatan RI : Dr. Ahmad Irsan A. Moeis, S.E., M.E
10.00 – 10.30	30	Sesi Tanya Jawab	Moderator : Drs Agoes Soelistyo Dunda, MM
10.30 – 11.30	60	Pemaparan Materi: Pemahaman Sistem Casemix dan Perkembangannya: dari ICD, DRG, CBG hingga Transformasi INA – CBG ke I - DRG	Narasumber Ahli: Prof Dato' Dr Syed Mohamed Ajunid (Professor of Health Economics and Senior Public Health Medicine Specialist)
11.30 – 12.00	30	Diskusi dan Klarifikasi Teknis	Moderator: dr. Ahmad Muzairi, M. Kes
12.00 – 13.15	75	Ishoma (makan siang)	
13.15 – 14.15	60	Pemaparan Materi: Strategi Optimalisasi Klaim di Era JKN: Kebijakan Rumah Sakit Menghadapi COB, I-DRG dan Dinamika Kebijakan Layanan Kesehatan	dr. Laura Mayanda, M. Kes (Case Mix Consultant)
14.15 – 14.45	30	Diskusi dan Klarifikasi Teknis	Moderator: dr. Ahmad Muzairi, M. Kes
14.45 – 15.15	30	Coffee Break	
15.15 – 16.00	45	Potensi Pengelolaan Dana Sosial melalui AUMKES	MPKU PP Muhammadiyah: dr Sholihul Absor, M. Kes
16.00 – 16.45	45	Sesi 1: Strategi Perencanaan dan Adaptasi Kebijakan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit serta Antisipasi Dampak Terhadap Cashflow di Era Transformasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan	RSIJ Cempaka Putih

Waktu	Durasi	Agenda	Penanggung Jawab
16.45 – 17.15	30	Sesi 2 : Kolaborasi Antar RSMA dan Inovasi Regional dalam Transisi Menuju i-DRG	MPKU Jawa Tengah: dr Bugar Wijiseno
17.15 – 17.45	30	Diskusi dan Klarifikasi Teknis	Moderator: Ketua MPKU PWM DIY: dr, Masykur Rahmat
17.45 – 18.30	45	ISHOMA	
18.30 – 19.15	45	Diskusi Kelompok (FGD): Pemetaan Kesiapan, Tantangan, dan Peluang RSMA dalam Implementasi I-DRG	Fasilitator MPKU dan Perwakilan Wilayah
19.15– 19.45	30	Pleno: Paparan Hasil FGD dan Penyusunan Rekomendasi Kelembagaan MPKU	Tim MPKU PP Muhammadiyah: 1. drg. Indria Nehriasari.,Sp.BM 2. dr. Ahmad Muzairi., M.Kes 3. dr. Masykur Rahmat 4. Drs. Agoes Soelistyo Dunda., MM
19.45 – 20.00	15	Finalisasi Rekomendasi RTL dan Penutup	Moderator: drg. Indria Nehriasari., Sp.BM., M.Kes

F. Penyelenggara

Kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sistem pengembangan dan konsolidasi Rumah Sakit Muhammadiyah–‘Aisyiyah (RSMA) secara nasional. Workshop ini dirancang sebagai forum internal konsolidasi nasional, yang tidak hanya merespons kebijakan Kementerian Kesehatan seperti Klasifikasi Layanan Berbasis Kompetensi, KRIS, dan iDRG, tetapi juga menjadi momentum penting bagi RSMA untuk:

- Menyusun langkah strategi untuk mengantisipasi gap adaptasi terhadap ketentuan baru Dimana akan sangat mempengaruhi ketahanan keuangan RSMA
- Merumuskan strategi kolaboratif antar RSMA dalam bidang coding dan keuangan
- Menghasilkan rekomendasi resmi kelembagaan kepada pemerintah

Konfirmasi kehadiran melalui Sdri Fistawati HP +628157998816 paling lambat 30 Mei 2025

F. Penutup

Demikian Term of Reference (TOR) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesiapan RSMA dalam menghadapi transformasi sistem kesehatan nasional serta menegaskan peran strategis Rumah Sakit Muhammadiyah–‘Aisyiyah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan.

Partisipasi aktif dan kontribusi seluruh peserta sangat diharapkan agar hasil workshop ini menghasilkan rumusan yang kuat, kontekstual, dan berdampak nyata bagi kemajuan layanan kesehatan RSMA di tingkat nasional.

Jakarta, 13 Juni 2025 M / 16 Dzulhijjah 1446 H
Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM
NBM : 551.318

PJ Workshop Keuangan,

Indria Nehriasari

drg. Indria Nehriasari, Sp. BM. MPH
NBM : 818.019

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
S8XMT-AVGUT-QAKGP-IGFUH

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
15 JUN 2025 05:06:19 UTC

SIGNER

TIMESTAMP

SIGNATURE

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
14 JUN 2025 23:07:14 UTC

VIEWED
14 JUN 2025 23:43:01 UTC

SIGNED
14 JUN 2025 23:44:33 UTC

M. Agus Samsudin

IP ADDRESS
103.18.34.237

LOCATION
JAKARTA, INDONESIA

INDRIA NEHRIASARI

EMAIL
NEHRIASARI1@YAHOO.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
14 JUN 2025 23:07:14 UTC

VIEWED
14 JUN 2025 23:13:24 UTC

SIGNED
15 JUN 2025 05:06:19 UTC

Indria Nehriasari

IP ADDRESS
125.165.226.14

LOCATION
YOGYAKARTA, INDONESIA



Term of Reference (TOR)
Workshop Executive Forum: Leadership for Transformative Collaboration
Pra-Rakernas MPKU PP Muhammadiyah 2025
Morazen Hotel Yogyakarta, 17 Juli 2025

A. LATAR BELAKANG

Transformasi sistem kesehatan nasional terus bergulir, ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Salah satu arah kebijakan penting yang saat ini dirancang oleh Kementerian Kesehatan adalah Klasifikasi Layanan Rumah Sakit Berbasis Kompetensi. Dalam skema ini, rumah sakit tidak lagi dikategorikan berdasarkan kapasitas fisik (kelas A, B, C, D), melainkan dinilai berdasarkan jenjang kompetensi pelayanan: Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. Penilaian mencakup integrasi SDM spesialis/subspesialis, infrastruktur, peralatan medis, dan kesiapan sistem informasi.

Bersamaan dengan itu, implementasi bertahap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem pembiayaan iDRG (*Indonesian Diagnosis Related Groups*) turut menambah kompleksitas transisi yang harus dihadapi rumah sakit. Ketiga kebijakan ini, meski belum sepenuhnya diberlakukan, memberikan sinyal kuat akan berubahnya lanskap perumahnya nasional secara menyeluruh—baik dalam aspek operasional, manajerial, maupun kemitraan layanan.

Di saat yang sama, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kesehatan berlangsung sangat cepat. Rumah sakit dituntut tidak hanya memenuhi standar layanan klinis, tetapi juga mampu mengintegrasikan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), terhubung dengan *platform* nasional seperti SATUSEHAT, serta mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti *telemedicine*, pemantauan jarak jauh, dan pemrosesan data kesehatan berbasis AI. Digitalisasi bukan lagi sekadar pendukung, tetapi menjadi prasyarat utama untuk efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, dan daya saing rumah sakit dalam ekosistem pelayanan kesehatan modern. Hal ini menjadikan transformasi digital sebagai elemen tak terpisahkan dari strategi kepemimpinan RSMA ke depan.

Bagi Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (RSMA), kebijakan ini menghadirkan tantangan nyata. Banyak RSMA, terutama di level menengah dan kecil, menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan SDM subspesialis, belum meratanya infrastruktur, serta beban investasi peralatan dan integrasi data. Tanpa strategi bersama dan kepemimpinan yang tangguh, RSMA berisiko tertinggal dalam proses transformasi ini—bahkan kehilangan akses pada skema pembiayaan JKN di masa mendatang.

Namun dalam setiap tantangan, tersimpan peluang. Kunci untuk merespons perubahan ini terletak pada kepemimpinan yang transformatif dan kolaboratif. RSMA tidak dapat bergerak sendiri. Diperlukan konsolidasi, penguatan jejaring layanan, dan kolaborasi lintas wilayah agar transformasi dilakukan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memimpin perubahan.

Dengan semangat itulah *Workshop Executive Forum: Leadership for Transformative Collaboration* diselenggarakan. Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan ruang konsolidasi para pemimpin RSMA untuk: membangun kesadaran bersama atas arah kebijakan, menyusun strategi kesiapan menghadapi klasifikasi berbasis kompetensi, serta menginisiasi kolaborasi nyata lintas unit dan wilayah. Kepemimpinan visioner dan sinergis menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa RSMA tidak hanya relevan, tetapi juga unggul dalam sistem kesehatan nasional yang terus berubah.

B. TUJUAN DAN LUARAN

Tujuan

1. Memperkuat kapasitas kepemimpinan RSMA/KMA dalam merespons kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya klasifikasi layanan rumah sakit berbasis kompetensi.

2. Mendorong kolaborasi strategis antar-RSMA melalui jejaring layanan, konsolidasi sumber daya, dan pembentukan *roadmap* transformasi bersama.
3. Meneguhkan nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam kepemimpinan dan tata kelola rumah sakit sebagai dasar dalam menghadapi tantangan kebijakan dan pelayanan.

Luaran yang Diharapkan

1. *Draft roadmap* transformasi RSMA/KMA 2025–2027, mencakup strategi peningkatan kompetensi layanan dan penguatan jejaring kolaboratif.
2. Dokumen pemetaan tantangan dan kebutuhan RSMA, sebagai dasar pengambilan keputusan internal dan prioritas penguatan kapasitas.
3. Rencana tindak lanjut antar-RSMA, berupa inisiatif konkret kolaborasi dalam peningkatan SDM, pemenuhan alat kesehatan, dan integrasi sistem informasi untuk kesiapan klasifikasi.

C. RUNDOWN KEGIATAN

Leadership for Transformative Collaboration

Hari/Tanggal: Kamis, 17 Juli 2025

Waktu: 08.00 – 20.30 WIB

Tempat: Hotel Morazen Yogyakarta

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan dan Pengantar Strategis: Kepemimpinan RSMA dalam Era Transformasi	Ketua MPKU PP Muhammadiyah
09.00 – 10.30	Sesi 1: <i>Hospital without Walls</i> – Kepemimpinan Kolaboratif untuk RSMA Berdaya Saing dan diskusi	Direktur Utama Philip Indonesia
10.30 – 12.00	Sesi 2: Tren dan Inovasi Farmasi dan Nutrisi dan diskusi	Direktur Utama Kalbe Farma – atau Direktur GE
12.00 – 13.00	ISHOMA	-
13.00 – 14.30	Sesi 3: Kunci Sukses Membangun RS Muhammadiyah Lamongan dan diskusi	dr. Umi Aliyah, M. Kes
14.30 – 15.15	Coffee Break	-
15.15 – 16.00	Sesi 4: Best Practice Transformasi Digital: Implementasi EMR dan Database Kesehatan RSMA-KMA - SehatMu	PJ dr. Nurcholid Umam Kurniawan, Sp. A., M. Sc.
16.00 – 17.00	Sesi 5: Kepemimpinan Islami dan Menjaga Misi Sosial di Tengah Disrupsi (SIRSMA)	dr. Agus Sukaca, M. Kes
17.00 – 19.00	ISHOMA	-
19.00 – 20.00	Sesi 6 (Refleksi Malam): Memimpin Kolaborasi Transformatif: Memperkuat Tata Kelola, Ideologi, dan Regenerasi Kader di Era Dinamis 1. Mewujudkan Kepemimpinan Ideologis dalam Tata Kelola dan Kaderisasi 2. Transformasi Tata Kelola Persyarikatan untuk Kolaborasi Strategis	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. Muhammad Sayuti, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D.
20.00 - 20.15	Penutupan dan Foto Bersama	Panitia

Sesi 1: *Hospital Without Walls* – Kepemimpinan Kolaboratif untuk RSMA Berdaya Saing

Narasumber: Direktur Utama Philips Indonesia

Paparan diharapkan menggambarkan perubahan paradigma rumah sakit masa kini yang tidak lagi terkungkung oleh batas fisik atau administratif. Narasumber dapat memaparkan bagaimana teknologi dan jejaring layanan memungkinkan rumah sakit menjangkau lebih luas, melayani dengan efisien, dan berkolaborasi lintas institusi. Ditekankan pula bagaimana bentuk kepemimpinan kolaboratif mampu memperkuat daya saing rumah sakit, dengan contoh konkret dari pengalaman Philips dalam membangun ekosistem layanan kesehatan berbasis kemitraan.

Sesi 2: Tren dan Inovasi Farmasi dan Nutrisi

Narasumber: Direktur Kalbe Farma

Paparan mencakup proyeksi tren kebutuhan farmasi dan nutrisi ke depan, terutama yang mendukung pelayanan rumah sakit yang adaptif dan berbasis evidence. Narasumber diharapkan memberi wawasan tentang bagaimana rumah sakit bisa membangun kolaborasi strategis dengan industri kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi logistik, dan diversifikasi revenue stream. Paparan juga dapat mencakup inovasi Kalbe dalam digitalisasi layanan dan kemitraan berkelanjutan.

Sesi 3: Kunci Sukses Membangun RS Muhammadiyah Lamongan

Narasumber: dr. Umi Aliyah, M.Kes.

Paparan bertujuan berbagi inspirasi dan praktik baik dari transformasi RSML menjadi rumah sakit rujukan regional. Fokus pada strategi kepemimpinan yang digunakan, pendekatan manajerial dalam pengembangan layanan unggulan, serta kunci keberhasilan dalam membangun SDM, infrastruktur, dan jejaring layanan. Narasumber dapat menekankan pentingnya konsistensi visi, kolaborasi lintas bidang, dan akuntabilitas dalam mengelola perubahan.

Sesi 4: Best Practice Transformasi Digital – Implementasi EMR dan Database Kesehatan RSMA-KMA (SehatMu)

Narasumber: dr. Nurcholid Umam Kurniawan, Sp.A., M.Sc.

Paparan memfokuskan pada pengalaman RSMA dalam menerapkan Electronic Medical Record (EMR) dan integrasi sistem SehatMu. Narasumber menjelaskan proses transformasi digital, tantangan dan solusinya, serta bagaimana EMR dan SehatMu mendukung efisiensi, keamanan data, dan integrasi dengan sistem nasional seperti SATUSEHAT. Ditekankan pula pentingnya kepemimpinan digital dan kolaborasi antar-RS dalam mempercepat transformasi sistem informasi kesehatan.

Sesi 5: Kepemimpinan Islami dan Menjaga Misi Sosial di Tengah Disrupsi (SIRSMA)

Narasumber: dr. Agus Sukaca, M.Kes

Paparan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam setiap transformasi. Narasumber diharapkan merefleksikan bagaimana tantangan disrupsi dan modernisasi tetap dapat direspon secara strategis tanpa meninggalkan jati diri dan misi sosial RSMA. Sesi ini menjadi ruang kontemplatif untuk meneguhkan orientasi spiritual dan nilai keadaban dalam kepemimpinan RSMA.

Sesi 6 (Refleksi Malam):

Memimpin Kolaborasi Transformatif: Memperkuat Tata Kelola, Ideologi, dan Regenerasi Kader di Era Dinamis

Narasumber 1: Dr. Agung Danarto, M.Ag. – Mewujudkan Kepemimpinan Ideologis dalam Tata Kelola dan Kaderisasi

Mengulas bagaimana kepemimpinan ideologis dan pembinaan kader menjadi fondasi penting dalam memperkuat kesinambungan gerakan Muhammadiyah, khususnya melalui sinergi antar struktur, ortom, dan Amal Usaha Muhammadiyah.

Narasumber 2: Muhammad Sayuti, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. – Transformasi Tata Kelola Persyarikatan untuk Kolaborasi Strategis

Membahas arah transformasi tata kelola organisasi yang adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk penguatan sistem kolaborasi antar bidang, integrasi digital, dan tata kelola kelembagaan yang profesional. Forum ini akan menjadi ruang reflektif dan strategis bagi pimpinan Persyarikatan dan AUM dalam memperkuat kolaborasi lintas struktur menuju gerakan yang lebih solid, relevan, dan berdaya ubah di tingkat lokal, nasional, maupun global.

D. PESERTA

1. Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah-'Aisyiyah (RSMA) peserta Rakernas MPKU 2025
2. BPH RS Muhammadiyah – 'Aisyiyah Peserta Rakernas MPKU 2025
3. Pimpinan Klinik Muhammadiyah-'Aisyiyah (KMA) Peserta Rakernas MPKU 2025

E. PENUTUP

Workshop Executive Forum – Leadership for Transformative Collaboration merupakan bagian strategis dari proses konsolidasi nasional Rumah Sakit Muhammadiyah-'Aisyiyah (RSMA) dalam menghadapi dinamika transformasi sistem kesehatan. Di tengah tekanan kebijakan, tuntutan efisiensi, dan kebutuhan jejaring layanan yang semakin kompleks, kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama keberlanjutan dan daya saing RSMA.

Forum ini dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar bersama, tetapi juga sebagai momentum reflektif dan penguatan komitmen para pimpinan RSMA dan Badan Pembina Harian untuk memimpin perubahan secara terarah. Melalui dialog strategis, simulasi kepemimpinan, dan penyusunan *roadmap* kolaborasi, workshop ini diharapkan menghasilkan arah bersama yang dapat mengakselerasi transformasi kolektif RSMA, sekaligus memperkuat posisi Persyarikatan dalam membangun sistem layanan kesehatan nasional yang adil, unggul, dan berkeadaban.

Partisipasi aktif, keterbukaan pikiran, serta komitmen tindak lanjut dari seluruh peserta akan menjadi kunci keberhasilan workshop ini dan menentukan arah masa depan kolaborasi RSMA secara nasional. TOR ini disusun sebagai acuan bersama untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif, sesuai dengan tujuan, waktu, dan hasil yang ditetapkan.

Jakarta, 10 Juni 2025 M / 14 Dzulhijjah 1446 H
Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM.
NBM : 551.318

Sekretaris,

Ekorini Listiowati

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR.
NBM : 908.340

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
MY8Y-KT4EB-9YAWQ-YFQQW

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
10 JUN 2025 09:33:05 UTC

SIGNER

TIMESTAMP

SIGNATURE

EKORINI LISTIOWATI

EMAIL
EKORINIKHOLID@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
10 JUN 2025 09:11:31 UTC

VIEWED
10 JUN 2025 09:15:17 UTC

SIGNED
10 JUN 2025 09:17:27 UTC

Ekorini Listiowati

IP ADDRESS
103.251.181.2

LOCATION
BANTUL, INDONESIA

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
10 JUN 2025 09:11:31 UTC

VIEWED
10 JUN 2025 09:28:20 UTC

SIGNED
10 JUN 2025 09:33:05 UTC

M. Agus Samsudin

IP ADDRESS
114.10.152.197

LOCATION
SURAKARTA, INDONESIA



Term of Reference
Rapat Kerja Nasional MPKU Muhammadiyah
Transformasi Kesehatan Muhammadiyah: Kolaborasi dan Inovasi
Hotel Morazen Yogyakarta, 17 – 19 Juli 2025

I. Latar Belakang

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah di bidang kesehatan saat ini mengelola lebih dari 125 Rumah Sakit Muhammadiyah-‘Aisyiyah (RSMA), lebih dari 200 Klinik Muhammadiyah-‘Aisyiyah (KMA), serta berbagai program kesehatan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia (MPKU PP Muhammadiyah, 2024). Sebagai organisasi dengan jaringan kesehatan terbesar di antara organisasi masyarakat sipil di Indonesia, MPKU dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan daya saing, ketangguhan, dan relevansi layanan di tengah perubahan lingkungan yang sangat dinamis.

Rencana Strategis MPKU 2023–2027 menempatkan tahun 2025 sebagai fase krusial dengan fokus pada perluasan jaringan dan penguatan layanan (MPKU PP Muhammadiyah, 2024). Target tersebut tidak hanya melibatkan pertumbuhan jumlah RSMA dan KMA, tetapi juga peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui standardisasi berbasis nilai Islami, adopsi teknologi informasi kesehatan, dan integrasi sistem layanan primer dan sekunder.

Dalam konteks nasional, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mendorong perubahan besar dalam regulasi, termasuk penguatan pelayanan kesehatan primer melalui skema Integrasi Layanan Primer (ILP), penekanan pada akreditasi layanan kesehatan, serta upaya membangun ketahanan kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Perubahan ini menuntut rumah sakit, klinik, dan bidang kesehatan masyarakat untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif.

Dalam lingkup internal, dinamika dunia kesehatan global memperlihatkan tren penguatan jejaring layanan kesehatan melalui holdingisasi rumah sakit. Konsep *holding* rumah sakit bukan hanya sekadar konsolidasi administratif, melainkan strategi transformasi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, berbagi sumber daya, memperkuat posisi tawar, dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bagi RSMA, penguatan kolaborasi dalam model *holding* menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan kompetisi dan regulasi baru.

Dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, berbagai RSMA telah memulai langkah kolaboratif sebagai strategi pengembangan maupun penyelamatan. Berbagai model kolaborasi ini menunjukkan inisiatif lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi sistem jejaring nasional yang lebih terstruktur. Contohnya adalah kolaborasi antara **RSI Kendal dan RSMA sekitarnya**, **RS PKU Muhammadiyah Gombong dengan jejaring regionalnya**, **RS ‘Aisyiyah Kudus dengan RS Sarkies ‘Aisyiyah**, **RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan jaringan klinik dan RSMA di sekitarnya**, serta **RS PKU Muhammadiyah Delanggu yang berperan dalam penguatan RSMA di Klaten dan sekitarnya**. Kolaborasi serupa juga dilakukan oleh **RS PKU Muhammadiyah Gamping dengan RSMA di Sleman dan Kulonprogo**, serta oleh **RS Islam Jakarta (RSIJ) Group dan jaringannya**, yang telah mengembangkan pola jejaring pelayanan dan manajemen lintas unit, baik untuk pengembangan kapasitas RSMA maupun penyelamatan RSMA yang menghadapi tantangan serius.

Praktik-praktik tersebut menjadi rujukan awal bahwa model jejaring, *holding*, ‘*hub and spoke*, atau bentuk kolaborasi terstruktur lainnya telah mulai tumbuh secara organik di lingkungan Muhammadiyah. Langkah-langkah ini perlu diperkuat dan dilembagakan dalam kerangka transformasi kesehatan nasional agar sistem pelayanan kesehatan Muhammadiyah mampu menjadi lebih efisien, responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Selain memperkuat aspek pelayanan dan kolaborasi jaringan, pengelolaan layanan kesehatan Muhammadiyah juga perlu dikembangkan secara komprehensif dari hulu ke hilir, termasuk dalam hal pengadaan obat, bahan habis pakai (BHP), dan alat kesehatan. Penguatan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan operasional RSMA dan KMA. Beberapa wilayah telah memulai inisiatif ini, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang telah membentuk unit usaha pengadaan alat kesehatan dan farmasi di bawah koordinasi PWM. Daerah Istimewa Yogyakarta juga sedang dalam tahap persiapan pembentukan unit serupa. Namun, di tingkat nasional, belum ada mekanisme tunggal dan terintegrasi yang mampu menjawab kebutuhan bersama secara luas dan sistematis. Oleh karena itu, usulan dan amanah untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di bawah Muhammadiyah menjadi semakin mendesak dan strategis untuk ditindaklanjuti, guna memastikan efisiensi biaya, kemandirian suplai, serta keberlanjutan layanan berbasis nilai Islam Berkemajuan.

Selain itu, kebutuhan mendesak untuk memperkuat manajemen risiko menjadi agenda utama. Dalam dunia kesehatan yang kompleks, risiko klinis, keuangan, dan operasional tidak bisa dihindari, namun dapat dikendalikan dan bahkan diubah menjadi peluang strategis. Pendekatan manajemen risiko berbasis peluang (*risk-based opportunity management*) menjadi kunci untuk membangun ketangguhan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah di tengah ketidakpastian global dan nasional (*World Bank*, 2024). *Risk-Based Opportunity Management* (RBOM) adalah pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya berfokus pada menghindari kerugian (*risk avoidance*), tetapi juga mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko sebagai peluang untuk pertumbuhan, inovasi, dan keunggulan organisasi.

Lebih jauh, pendekatan kesehatan masyarakat saat ini menekankan pentingnya pergeseran dari kuratif ke promotif dan preventif, sejalan dengan penguatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama. MPKU perlu memperkuat *community engagement* melalui kolaborasi lintas Amal Usaha Muhammadiyah - 'Aisyiyah seperti sekolah, pesantren, panti asuhan, serta jejaring majelis dan lembaga lainnya, seperti *Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN)* serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah - 'Aisyiyah (PTMA). Penguatan kolaborasi ini bukan saja memperluas jangkauan program kesehatan masyarakat dan menjamin keberlanjutannya, tetapi juga memperkuat dakwah Muhammadiyah berbasis pelayanan kesehatan yang berkeadaban (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Melihat tantangan dan peluang tersebut, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MPKU PP Muhammadiyah Tahun 2025 menjadi sangat strategis. Rakernas ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi capaian, tetapi lebih jauh untuk:

1. Menetapkan arah transformasi layanan kesehatan Muhammadiyah melalui penguatan kolaborasi dan inovasi,
2. Merumuskan strategi pengelolaan risiko yang proaktif, adaptif, dan transformatif,
3. Meningkatkan peran RSMA, KMA, dan MPKU Wilayah/Daerah sebagai pelopor pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, dan berbasis komunitas dengan berlandaskan nilai-nilai Islam Berkemajuan.
4. Rakernas MPKU 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi besar untuk memastikan bahwa Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah bukan hanya bertahan, tetapi menjadi pemimpin dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih unggul, adil, tangguh, dan inklusif di masa depan.

II. Tema dan Tujuan Kegiatan

Tema Kegiatan

"Transformasi Kesehatan Muhammadiyah: Kolaborasi dan Inovasi"

Tema ini dipilih untuk menegaskan arah strategis MPKU PP Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika kesehatan nasional dan global, sekaligus mempercepat transformasi jaringan layanan kesehatan Muhammadiyah menjadi lebih kolaboratif, inovatif, tangguh, dan berbasis nilai-nilai Islam Berkemajuan. Rakernas ini menjadi tonggak konsolidasi gerakan untuk memperkuat jejaring RSMA, KMA, dan MPKU Wilayah/Daerah, mengoptimalkan peluang melalui manajemen risiko yang transformatif, serta meningkatkan

dampak layanan promotif dan preventif berbasis keterlibatan komunitas.

Tujuan Kegiatan

1. Mengonsolidasikan transformasi layanan kesehatan Muhammadiyah melalui penguatan kolaborasi antar RSMA, KMA dan MPKU Wilayah/Daerah, termasuk pengembangan model jejaring atau *holding* untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan daya saing.
2. Mendesiminasikan berdirinya badan usaha tingkat nasional berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di bawah PP Muhammadiyah dalam kerangka membangun komitmen bersama dengan tujuan utama mengkonsolidasikan penguatan rantai pasok yang efektif dan efisien serta terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan operasional RSMA dan KMA guna memastikan efisiensi biaya, kemandirian suplai, serta keberlanjutan layanan kesehatan berbasis nilai Islam Berkemajuan.
3. Menyusun strategi manajemen risiko berbasis peluang untuk memperkuat ketangguhan rumah sakit, klinik, dan bidang kesehatan masyarakat Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan dinamika eksternal.
4. Meningkatkan integrasi layanan promotif dan preventif berbasis komunitas dengan memperkuat peran aktif MPKU Wilayah dan MPKU Daerah dalam kolaborasi lintas Amal Usaha Muhammadiyah (sekolah, pesantren, panti asuhan dan lainnya), serta lintas Majelis, Lembaga, dan Ortom melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mendorong inovasi layanan berbasis teknologi informasi serta memperkuat implementasi nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam seluruh layanan kesehatan Muhammadiyah.

III. Keluaran Kegiatan

Rakernas MPKU PP Muhammadiyah Tahun 2025 ditargetkan menghasilkan:

1. Roadmap Penguatan Jejaring dan Pengembangan RSMA-KMA untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kolaborasi layanan kesehatan Muhammadiyah - 'Aisiyyah.
2. Strategi Manajemen Risiko dan Ketangguhan AUM Kesehatan untuk mengubah risiko menjadi peluang inovasi dan memperkuat keberlanjutan layanan.
3. Pedoman Standarisasi RSMA dan Klinik sebagai Rumah Sakit Islami berbasis nilai-nilai Islam Berkemajuan dengan fokus mutu, etika, dan budaya organisasi.

IV. Schedule Kegiatan

Waktu kegiatan : Kamis – Sabtu, 17 – 19 Juli 2025 M / 12 – 14 Muharram 1447 H

Tempat kegiatan : Hotel Morazen Yogyakarta

Jl. Nasional III Yogyakarta - Purworejo KM 41.5, KM 41.5, Kulon Progo, DIY 55654

HARI I: Kamis, 17 Juli 2025 – Workshop Pra Rakernas MPKU PP Muhammadiyah

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator / PJ
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta Workshop	-	Panitia
08.30 – 20.30	Workshop 1: <i>Executive Forum – Leadership for Transformative Collaboration</i>	Pakar Manajemen Kesehatan	MPKU PPM
08.30 – 20.30	Workshop 2: Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di era Transformasi Pelayanan Kesehatan Nasional: Tinjauan, Kesiapan, dan Kesempatan RSMA dalam menghadapi perubahan regulasi menjadi I DRG	Pakar Pembiayaan Kesehatan	MPKU PPM
13.00 – 20.30	Workshop 3: Digitalisasi Sistem Pelayanan RSMA – Strategi Interoperabilitas, Efisiensi, dan Keamanan Data	TTDK Kemenkes RI Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI	MPKU PPM
	Workshop 4: Sinergi dan kolaborasi Majelis/Lembaga/Ortom	MPKU PPM	MPKU PPM
20.30 – 20.45	Penutup		MPKU PPM

HARI II: Jum'at, 18 Juli 2025 – Pleno & Pembukaan Rakernas MPKU PP Muhammadiyah 2025

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator / PJ
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta Rakernas	-	Panitia
09.00 – 09.45	Pembukaan Resmi Rakernas: 1. Tilawah 2. Lagu Indonesia Raya & Sang Surya 3. Sambutan & Laporan Ketua MPKU sekaligus launching PT MENTARI MEDIKA INDONESIA SehatMu	Dr. H.M. Agus Samsudin, MM	Panitia PT Mentari Medika Indonesia LabMu - SehatMu
09.45 – 10.30	Sinergi dan kolaborasi – pemberdayaan ekonomi RS dan Klinik Muhammadiyah – 'Aisyiyah (pengadaan obat, BMHP, dan alkes)	Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP	MPKU PPM
10.30 – 11.15	Amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah: Arah Dakwah Kesehatan Berkemajuan di Era Disrupsi	Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si	MPKU PPM
11.15 – 12.00	Pemaparan Rencana Strategis MPKU PP Muhammadiyah 2024 - 2027	Ketua Tim Renstra MPKU 2024-2027 Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M. Kes	MPKU PPM
12.00 – 13.00	ISHOMA	-	Panitia
13.00 – 13.30	Kebijakan BPJS dan Skema Pembiayaan Layanan Kesehatan Berbasis Mutu	Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan (dr. Lily Kresnowaty, M. Kes)	dr. Ahmad Faesol, Sp. Rad., M. Kes. MMR
13.30 – 14.00	Penguatan Peran Rumah Sakit dan Klinik Swasta dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan: Adaptasi Regulasi, Mutu Layanan dan Digitalisasi (termasuk Klasifikasi Layanan RS Berbasis Kompetensi)	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan (Dirjen Kesehatan Lanjutan) (dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS)	
14.00 – 15.00	Diskusi Panel	BPJS dan Dirjen Yankes	
15.00 – 15.15	Coffee Break	-	-
15.15 – 15.45	<i>From Data to Decisions: Enhancing Hospital Efficiency through Digitization</i>	GE Healthcare	Panitia
15.45 – 17.30	Membangun SDM Kesehatan Muhammadiyah	Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah FKIK UMY	Moderator:
17.30 – 19.30	ISHOMA	-	-
19.30 – 21.00	Penganugerahan MPKU Award		MPKU PPM

HARI III: Sabtu, 19 Juli 2025 – Konsolidasi, Rekomendasi, dan Penutupan

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator / PJ
08.30 – 10.30	<i>Digital Marketing</i> dalam dunia kesehatan	META Indonesia Digital Mediatama MAXIMA	
10.30 - 10.45	Presentasi Produk (Sponsor)	Sponsor	-
10.45 - 11.30	Motivasi & Refleksi: RSMA sebagai Pusat Pelayanan, Dakwah, dan Keunggulan Islam Berkemajuan	dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp. S., M. Kes	
11.30 - 12.00	Penutupan Resmi Rakernas	Ketua PP Muhammadiyah: dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp. S., M. Kes	Panitia
12.00 - 13.00	Makan siang dan sholat		

V. Deskripsi Pra Raker Workshop dan MPKU Award

Pra-Rakernas MPKU PP Muhammadiyah 2025: Workshop Paralel

(Hari Pertama: 1 Hari Workshop, 4 Kelompok Paralel)

Workshop 1: Executive Forum – Leadership for Transformative Collaboration

(Hari Pertama Kamis, 17 Juli 2025 pukul 08.30 - 20.30)

Sasaran

Peserta workshop terdiri dari pimpinan eksekutif Rumah Sakit Muhammadiyah-'Aisyiyah (RSMA), Badan Pembina Harian (BPH), serta perwakilan dari Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Wilayah. Forum ini ditujukan untuk para pengambil kebijakan dan pemimpin strategis yang berperan dalam mengarahkan transformasi kelembagaan dan layanan RSMA di tengah dinamika kebijakan nasional dan perkembangan teknologi kesehatan.

Peserta:

1. Direktur/Direktur Utama RSMA
2. Badan Pembina Harian RSMA
3. MPKU Wilayah/Daerah Pendiri RSMA
4. Pimpinan Klinik MA

Tujuan Kegiatan

1. Memperkuat kapasitas kepemimpinan RSMA dalam merespons transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya kebijakan klasifikasi layanan rumah sakit berbasis kompetensi, digitalisasi, dan iDRG.
2. Membangun kesepahaman kolektif atas pentingnya kolaborasi antar-RSMA sebagai strategi adaptif menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saing.
3. Meneguhkan nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam praktik kepemimpinan dan tata kelola rumah sakit Muhammadiyah-'Aisyiyah.

Topik Rinci

1. Kepemimpinan Kolaboratif dalam Era Disrupsi: Menyajikan model kepemimpinan lintas batas institusi dan pengalaman dari industri teknologi kesehatan.
2. Jejaring dan Inovasi Layanan: Berbagi praktik baik jejaring layanan dan inovasi farmasi-nutrisi sebagai peluang kolaboratif.
3. Studi Kasus RSML dan Digitalisasi EMR: Pembelajaran dari pengalaman transformasi rumah sakit anggota, termasuk digitalisasi berbasis SehatMu.
4. Dialog Strategis Antar Wilayah: Menyusun kesepahaman arah kolaborasi strategis antar RSMA wilayah dan lembaga terkait.
5. Refleksi Nilai Islami dalam Kepemimpinan RSMA: Menjaga akar ideologis dan sosial RSMA di tengah disrupsi sistem layanan.

Hasil yang Diharapkan

1. Terbentuknya kesepakatan awal arah kolaborasi dan sinergi antar-RSMA dalam penguatan layanan dan sistem informasi.
2. Munculnya rencana aksi dan komitmen pimpinan RSMA dalam menanggapi kebijakan nasional dan peluang transformasi digital.
3. Tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan misi sosial RSMA dalam setiap langkah pengembangan rumah sakit.

Workshop 2: Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di era Transformasi Pelayanan Kesehatan Nasional: Tinjauan, Kesiapan, dan Kesempatan RSMA dalam menghadapi perubahan regulasi menjadi I DRG

(Hari Pertama Kamis, 17 Juli 2025 pukul 08.30 - 20.30)

Sasaran Peserta:

- Direktur Keuangan RSMA
- Direktur Pelayanan Medik RSMA
- Manajer Penunjang dan Pelayanan Medik
- Manajer Keuangan
- Manajer JKN/Casemix

Tujuan Workshop:

- Meningkatkan pemahaman kolektif RSMA tentang kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan berbasis *i-DRG*.
- Mengidentifikasi tantangan dan kesiapan RSMA terkait kebijakan *i-DRG* dari aspek SDM, infrastruktur, sistem informasi, dan manajerial.
- Menyusun roadmap kesiapan RSMA secara nasional dan regional dalam menyongsong sistem klasifikasi layanan berbasis kompetensi.
- Membangun strategi kolaborasi antar-RSMA untuk adaptasi kebijakan dan penguatan kapasitas.
- Merumuskan rekomendasi kelembagaan kepada Kementerian Kesehatan agar implementasi *i-DRG* dilakukan secara bertahap dan adil.

Topik Rinci Workshop:

- Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait pembiayaan berbasis *i-DRG*
- Strategi penyesuaian coding dan klaim berbasis *i-DRG*
- Studi kasus RSIJ Cempaka Putih
- Sesi berbagi praktik RSMA (perencanaan kebijakan, penguatan SDM & sistem informasi, pengelolaan keuangan, kolaborasi regional)
- Diskusi kelompok (FGD) pemetaan kesiapan RSMA
- Pleno penyusunan rekomendasi kelembagaan MPKU

Hasil yang Diharapkan:

- Dokumen pemetaan kesiapan dan tantangan RSMA dalam implementasi *i-DRG*.
- Strategi implementatif dan langkah konkrit untuk kesiapan data dan pengajuan klaim.
- Rencana kolaboratif peningkatan SDM, sarana, dan sistem informasi.
- Dokumen roadmap nasional dan regional kesiapan RSMA.
- Rekomendasi kelembagaan resmi MPKU PP Muhammadiyah kepada pemerintah.
- Penguatan jejaring dan koordinasi antar RSMA dalam menyikapi transformasi pembiayaan layanan kesehatan.

Workshop 3: Digitalisasi Sistem Pelayanan RSMA – Strategi Interoperabilitas, Efisiensi, dan Keamanan Data

(Hari Pertama Kamis, 17 Juli 2025 pukul 09.00 - 21.00)

Sasaran Peserta:

- Tim IT RS Muhammadiyah–‘Aisyiyah (RSMA) se-Indonesia
- Coder RSMA se-Indonesia
- Perwakilan Direksi RSMA
- MPKU PWM dan MPKU PDM
- Undangan mitra strategis

Tujuan Workshop:

- Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas tim IT RSMA terhadap kebijakan dan sistem nasional (SATUSEHAT, keamanan data).
- Menyusun roadmap digitalisasi RSMA secara kolektif.
- Memperkuat kolaborasi dan jaringan antar-tim IT RSMA secara nasional.

Topik Rinci:

- Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait transformasi digital kesehatan
- Integrasi SIMRS dengan SATUSEHAT dan sistem BPJS
- Finalisasi standar interoperabilitas: KFA, LOINC, SNOMED, Metadata
- Penerapan AI dalam EMR dan automasi klinik
- Transisi coding ICD-9 & ICD-10 menuju IDRG Nasional
- Cybersecurity dan keamanan data di RSMA
- Workshop teknis: integrasi EMR, enkripsi data, interoperabilitas, klaim BPJS, dan audit keamanan

Hasil yang Diharapkan:

- Draft roadmap digitalisasi RSMA 2025–2027
- Rekomendasi teknis dan kelembagaan dalam implementasi EMR terintegrasi
- Peningkatan kapasitas SDM dan sistem keamanan data RSMA
- Tersusunnya standar interoperabilitas bersama RSMA
- Penguatan jejaring dan kolaborasi antarunit IT RSMA di seluruh Indonesia

Workshop 4: Sinergi dan Kolaborasi Lintas Majelis/Lembaga/Ortom

(Hari Pertama Kamis, 17 Juli 2025 pukul 13.00 - 20.30)

Sasaran Peserta

Total peserta: 55 orang, terdiri dari:

- MPKU PWM se-Indonesia
- Majelis Kesehatan PP 'Aisyiyah
- Perwakilan Majelis/Lembaga dan Ortom
- PTMA

Deskripsi Singkat

Kegiatan **Launching dan Focus Group Discussion (FGD)** ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi lintas Majelis dan Lembaga di lingkungan Muhammadiyah dalam penguatan pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial berbasis komunitas. Kegiatan ini akan meluncurkan program kolaboratif *Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan* sebagai pilot project nasional yang bertujuan menyiapkan generasi sehat, tangguh, dan berkemajuan, serta menyusun rencana tindak lanjut untuk replikasi program di tingkat wilayah.

Tujuan

1. Meluncurkan program kolaboratif kesehatan masyarakat lintas majelis di tingkat nasional: *Generasi Muhammadiyah (GenMu) Sehat Berkemajuan*.
2. Meningkatkan pemahaman antar-majelis/lembaga mengenai sinergi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan sosial.
3. Merancang program kesehatan masyarakat inovatif dengan pembagian peran antar Majelis/Lembaga/Ortom
4. Menyusun rencana tindak lanjut kolaborasi dan membentuk tim koordinasi lintas majelis untuk menjamin keberlanjutan program.

MPKU Award

Tema: *Transformasi Kesehatan Muhammadiyah: Kolaborasi dan Inovasi*

Tujuan Kegiatan:

- Memberikan penghargaan untuk inovasi di bidang:
 - Pelayanan RS/Klinik Muhammadiyah-'Aisyiyah
 - Digitalisasi sistem dan layanan
 - Implementasi AI-Islam Kemuhammadiyah
 - Program Kesehatan Masyarakat
- Menyediakan referensi praktik baik bagi AUM Kesehatan dan MPKU di berbagai tingkatan

Kategori dan Peserta:

1. Inovasi Pelayanan RS – RS Muhammadiyah/'Aisyiyah
2. Inovasi Pelayanan Klinik – Klinik Muhammadiyah/'Aisyiyah
3. Inovasi Digitalisasi – RS/Klinik/MPKU Wilayah/Daerah
4. Inovasi AI-Islam Kemuhammadiyah – RS/Klinik/MPKU/PTMA Kesehatan
5. Inovasi Program Kesehatan Masyarakat – RS/Klinik/MPKU/AUM Pendidikan/Sosial/Ortom

Keluaran (Output):

- Video profil program berdurasi maks. 8 menit
- Dokumentasi pendukung: artikel, berita, laporan, foto, dsb.

Tahapan Kegiatan:

- 7 Mei–15 Juni: Sosialisasi & publikasi
- 16–22 Juni: Pendaftaran & pengumpulan dokumen
- 23–25 Juni: *Desk review* oleh panitia
- 26 Juni–5 Juli: Penjurian tahap 1 (*review video*)
- 7–12 Juli: Penjurian tahap 2 (*presentasi nominasi*)
- 26 Juni–18 Juli: Penayangan video di *YouTube* MPKU
- 18 Juli: Pengumuman dan penganugerahan MPKU Award di Rakernas MPKU

Kriteria Penilaian:

- Gagasan/inovasi program
- Dampak/manfaat program
- Kolaborasi
- Kreativitas & kualitas video (alur cerita, sinematografi, talent, lokasi)

VI. Peserta

Peserta

PP Muhammadiyah	: 1 orang
PP 'Aisyiah	: 1 orang
Majelis/Lembaga/Biro/Ortom	: 15 orang
Dewan Pakar MPKU PP Muhammadiyah	: 7 orang
Pimpinan MPKU PP Muhammadiyah	: 32 orang
Ketua Majelis Kesehatan PPA & PWA	: 15 orang
Ketua PWM Bidang Kesehatan	: 26 orang
Ketua & Sekretaris MPKU PWM Selindo	: 52 orang
Badan Pembina Harian (BPH) RSMA	: 20 orang
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan PTMA Selindo	: 20 orang
Direksi RSMA	: 150 orang
Pimpinan Klinik / AUK Muhammadiyah.	: 40 orang

Kesekretariatan dan panitia
Forum IT – Rekam Medik

: 25 orang
: 75 orang

VII. Kepanitiaan

PELINDUNG :

dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes. – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pembinaan Kesehatan Umum, Kesejahteraan Sosial, dan Resiliensi Bencana

PENANGGUNG JAWAB :

Dr. Drs. H. Mohammad Agus Samsudin, MM. – Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah

PENGARAH

1. Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
2. dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A., MPH.
3. dr. Sholihul Absor, M.Kes.
4. Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.
5. Dr. dr. Slamet Budiarto, SH., MH.Kes.

TIM DANA DAN SPONSORSHIP

Ketua : dr. Dirwan Suryo Soularto, Sp.F., M.Sc.
Anggota : Agoes Soelistiyo Dunda
Nuri Indrastuti, S.Kp., MPH.

PELAKSANA

Ketua : Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR.
Wakil Ketua 1 : dr. Ahmad Faesol, Sp.Rad., M.Kes., MMR.
Wakil Ketua 2 : Agus Budiantoro, SIP., SAP.
Wakil Ketua 3 : Dr. Warsiti, S.Kep., M.Kep, Sp.Mat.

Sekretaris : Dr. Husnan Nurjuman, S.Ag., M.Si.
Wakil Sekretaris 1 : Siti Salimah, S.Si, Apt., M.Kes.
Wakil Sekretaris 2 : Didin Sahidin, SKM., MKM.

Bendahara : dr. Dirwan Suryo Soularto, Sp.F., M.Sc.
Wakil Bendahara 1 : Eka Wulandari, S.Sos., MM.
Wakil Bendahara 2 : Yuliana Safitri, SE.

PJ Workshop 1 : Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR.
PJ Workshop 2 : drg. Indria Nehriasari, Sp.BM., MPH.
PJ Workshop 3 : dr. Nurcholid Umam, Sp.A., M.Kes.
PJ Workshop 4 : Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.
PJ MPKU Award : Dr. Husnan Nurjuman, S.Ag., M.Si

Anggota :

1. Dr. dr. Gea Pandhita, Sp.S., M.Kes.
2. Lia Karisma Saraswati, M.Kes.
3. Mei Rizki Dini, Amd.
4. Dimas Catur Ihtifazhuddin, S.Kom.
5. Oki Wahyu Nugroho, S.Kom.
6. Darmawan Saputra, S.Kom.
7. Supriyanto

8. Yuanita Wulandari, S.Kep., Ns., M.Sc.
9. dr. Cinyanna Taritasari
10. Wahyu Titis Dwirani, S.Kom., M.Kom.
11. dr. Khansa Maria Salsabila
12. dr. Farhan Arvyan
13. Muhammad Faruqi Abdurrasyid
14. Alfis Khoirul Khisoli, S.Kom.I., MSi.
15. Fistawati Nuri Subroto, SE.
16. dr. Masykur Rahmat
17. Muchammad Rifai, SKM., MSc.
18. Alif Khoirudin Azizi, SE., MMR.
19. Ismail Setia Budi, S. Sos. I.

VIII. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini menggunakan dana MPKU PP Muhammadiyah, dana bantuan atau sponsorship dan kepesertaan Rumah Sakit Muhammadiyah 'Aisyiyah sebagai berikut :

1. Kepesertaan Rakernas MPKU 2025
 - a. Sumbangan Wajib Organisasi (SWO) Rp 4.000.000 per RSMA
 - b. Sumbangan Wajib Peserta (SWP) Rp 3.000.000 per peserta dari RSMA dan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan PTMA (di luar penginapan)
2. Kepesertaan WS Executive Forum – Leadership (free untuk peserta Rakernas MPKU 2025)
3. Kepesertaan WS Keuangan
 - a. Free untuk peserta Rakernas MPKU 2025
 - b. Di luar peserta Rakernas MPKU 2025 – SWP Rp 1.000.000 per peserta (di luar penginapan)
4. Kepesertaan WS Digitalisasi
 - a. Dengan penginapan SWP Rp 1.600.000 per peserta
 - b. Tanpa penginapan SWP Rp 1.450.000 per peserta
5. Kepesertaan WS Kesehatan Masyarakat
 - a. Free untuk peserta Rakernas MPKU 2025
 - b. Di luar peserta Rakernas MPKU 2025 – SWP Rp 500.000 per peserta (di luar penginapan)
6. Sponsorship dari RSMA
7. Sponsorship dari Fakultas Kedokteran
8. Sponsorship Produk/booth-pameran

IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai tujuan, target, jadwal dan anggaran yang ada.

Jakarta, 30 Juni 2025 M/04 Muharram 1447 H
Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM
NBM : 551.318



Sekretaris,

Ekorini Listiowati

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR
NBM : 908.340

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
XBTVH-PORCK-MSU9M-FBIUQ

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
30 JUN 2025 22:36:49 UTC

SIGNER

TIMESTAMP

SIGNATURE

EKORINI LISTIOWATI

EMAIL
EKORINIKHOLID@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
30 JUN 2025 12:55:10 UTC

VIEWED
30 JUN 2025 13:06:46 UTC

SIGNED
30 JUN 2025 13:09:31 UTC

Ekorini Listiowati

IP ADDRESS
103.119.66.88

LOCATION
JAKARTA, INDONESIA

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
30 JUN 2025 12:55:10 UTC

VIEWED
30 JUN 2025 22:34:38 UTC

SIGNED
30 JUN 2025 22:36:49 UTC

M. Agus Samsudin

IP ADDRESS
103.18.34.237

LOCATION
DEPOK, INDONESIA

